Rastlinná strava a nižšia mortalita u pacientov s CKD: čo z toho využiť v praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Prevaha rastlinnej stravy sa spája s lepším prežívaním – pri CKD však treba strážiť draslík a fosfor.

Na 63. kongrese ERA boli prezentované výsledky multikohortovej analýzy (z databáz NHANES a HCNS), ktorá sledovala, či kvalita stravy súvisí s dlhodobými výsledkami u pacientov s **chronickou chorobou obličiek (CKD)**.

CKD bolo definované ako **eGFR < 60 ml/min/1,73 m²** a/alebo prítomnosť albuminúrie. Celkovo bolo zahrnutých **8 165 dospelých**, pričom medián sledovania trval približne **7 až 8 rokov**.

Porovnávané stravovacie modely

Autori porovnávali mieru dodržiavania (adherencie) štyroch stravovacích modelov:

- **DASH** (Dietary Approaches to Stop Hypertension),
- **stredomorská strava** (Mediterranean),
- **Planetary Health Diet (PHD)** – strava pre zdravie planéty,
- **Inverted Pyramid Diet** – „obrátená potravinová pyramída“.

Hlavné výsledky (mortalita)

Súvislosť s mortalitou sa zistila pri všetkých hodnotených modeloch, no **najsilnejšia** bola pri **Planetary Health Diet (PHD)**. Každé zvýšenie adherencie o 1 štandardnú odchýlku znamenalo:

- **o 17 % nižšie riziko úmrtia zo všetkých príčin** (HR 0,83; 95 % CI 0,78–0,89; p < 0,001),
- **o 24 % nižšie riziko úmrtia súvisiaceho s obličkami** (HR 0,76; 95 % CI 0,64–0,90; p = 0,001).

Aj **DASH** a **stredomorská strava** súviseli s nižšou celkovou mortalitou, no veľkosť účinku bola menšia.

Naopak, **Inverted Pyramid Diet** bola spojená s **horšími výsledkami**:

- **o 18 % vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin** (HR 1,18; 95 % CI 1,10–1,27; p < 0,001),
- **o 32 % vyššie riziko úmrtia súvisiaceho s obličkami** (HR 1,32; 95 % CI 1,12–1,56; p = 0,001).

Čo konkrétne zhoršovalo prognózu

Ďalšia analýza ukázala, že:

- **ultraspracované potraviny** tvoriace **aspoň 30 % celkového energetického príjmu** zvyšovali riziko úmrtia o **24 %**,
- **vyšší príjem červeného mäsa** (definovaný ako **4 a viac porcií týždenne**) bol spojený s **o 19 % vyšším rizikom úmrtia**.

Praktické ponaučenie pre nefrologickú ambulanciu

Tento zdroj neponúka liečebný algoritmus „na predpis“, ale dáva praktický smer: pri CKD má zmysel hovoriť s pacientom o **kvalite stravy**. Rozumné je podporovať model, ktorý:

- je **prevažne rastlinný** a stojí na **minimálne spracovaných** potravinách,
- **obmedzuje ultraspracované** produkty,
- a **reálne znižuje príjem červeného mäsa**.

Pri interpretácii treba pamätať, že ide o **pozorovaciu analýzu** a kongresový abstrakt, nie o dôkaz príčinnej súvislosti. V praxi môže byť pri CKD problémom aj individuálna nutričná tolerancia (napr. príjem bielkovín, riziko sarkopénie pri nevhodne „prehnanom“ rastlinnom režime). Najlepšie funguje skríning nutričného stavu a cielené odporúčanie v spolupráci s dietológom.

Zdroj: *EMJ Reviews (ERA Congress, 2026): „Plant-Based Diet Linked to Lower Mortality in CKD“.* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rastlinna-strava-nizsia-mortalita-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.